



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : جيهان حسن احمد سليم

العنوان : ****

المحافظة : الجيزة

رقم البطاقة : 26609252102364 رقم التليفون : 01016264234

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-09-1966 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطه العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي Anthracyclines base [14151]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطه العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: جيهان حسن احمد سليم National ID: 26609252102364	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Anthracycline-based chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



جيهان
حسن احمد سليم
٤٩ ش حجاج عبدالرحيم
امبابة - الجيزة

١٩٩٦/٠٩/١٩ ٢٦٦.٩٢٥٢١.٢٣٦٤

LR8063858

Dms
مستند
مصري

٢٠٢٦/٠٤ ٢٦٦.٩٢٥٢١.٢٣٦٤

حاصلة على دبلوم تجارة

أنثى مسجلة أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٤/١١ ١





هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
معهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
الأمراض المعدية

قسم الباثولوجي

تم الرد

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: جيهان حسن احمد سليم

Request type: مبادره

Hospital no:

Department: صحة مراه

Referred by: د/مروه حسن

Nature of specimen: tru- cut biopsy

Clinical diagnosis: right breast mass

Age: 60years

Sex: female

Sub request type:

Pathology no.: 288B-2026

Date of result: 16/5/2026

Date of biopsy: 30/4/2026

I.D. Number: 26609252102364

Gross pathology: Multiple gray white tissue cores up to, 1cm long. Totally submitted. Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue show malignant growth formed of files, tubules, nests and cords infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and mild tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. There is focal solid ductal carcinoma insitu of low grade. No lymphovascular invasion or perineural infiltration in core tissue examined.

Immunohistochemical Result:

ER: Strong Positive nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining of 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (Score 0). Negative

Ki67: Positive nuclear staining of 30% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass; tru- cut biopsy:

Invasive mammary carcinoma, grade II

Signature:

Dr. Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Dr. Gehan Hasan Ahmed

Date: 7/4/2026

**DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY
WITH COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF
BOTH BREASTS REVEALED:**

- ACR A: Mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen at the UOQ of the right breast corresponding by US to an ill-defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion, vascularity is seen at 11 o'clock surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing. It measures 20x12 mm in its max dimensions, (BIRADS V) for biopsy.
- Few enlarged axillary LNs one of them showing increased cortical thickness (4mm) and effaced fatty hilum. The largest measures 18 mm.
- No pathological microcalcification clusters.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.

Opinion:

- Right breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V); for pathological correlation.

Much Obligated;

Dr. Marwa Adel, MSc, FEBR

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0: Needs further investigations.

BIRADS 1: Normal findings.

BIRADS 2: Benign.

BIRADS 3: Probably benign.

BIRADS 4: Probably malignant.

BIRADS 5: Malignant.

BIRADS 6: Proven pathologically malignant

Medical No. : 3326

Patient's Name: Gihan Hassan Ahmed Selim

Date: 2026-09-26

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



REAL TIME NECK ULTRASOUND

□ Thyroid gland: [in normal site]

Vague history of right hemithyroidectomy

- The left thyroid gland showing diffusely scattered hypoechoic spongiform multiple nodules variable in sizes largest measuring 7x7mm
- The left lobe measures 1.4 x 1.5 x 4 cm.
- The isthmus measures 0.45 cm in height.
- No retro-sternal extension.
- Central trachea.

- Right enlarged cervical lymph node with preserved fatty hilum (reactionary).

CONCLUSION:

- Multiple Left thyroid nodules as described (TIRAD 4) for clinical correlation and follow up.

Best regards,

DR. Sahl Mahmoud

Medical No. : 3326

Patient's Name: Gihan Hassan Ahmed Selim

Date: 2026-09-26

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



REAL TIME NECK ULTRASOUND

□ Thyroid gland: [in normal site]

Vague history of right hemithyroidectomy

- The left thyroid gland showing diffusely scattered hypoechoic spongiform multiple nodules variable in sizes largest measuring 7x7mm
- The left lobe measures 1.4 x 1.5 x 4 cm.
- The isthmus measures 0.45 cm in height.
- No retro-sternal extension.
- Central trachea.

□ Right enlarged cervical lymph node with preserved fatty hilum (reactionary).

CONCLUSION:

- Multiple Left thyroid nodules as described (TIRAD 4) for clinical correlation and follow up.

Best regards,

DR. Sahl Mahmoud